

Razonamiento clínico — Muñeca / Mano

bodyPart: wrist_hand · entry: wh_master_entry

Árbol interactivo de razonamiento clínico (Physioguide / AIKinora). Uso educativo para fisioterapeutas. No sustituye valoración presencial.

Nodos totales: 13

Entrada alternativa por test del informe

- **phalen** → wh_phalen
- **tinel** → wh_tinel
- **ultr** → wh_ultr
- **finkelstein** → wh_finkelstein

Flujo de nodos (desde la entrada)

1. [CONCLUSIÓN] Muñeca / mano — árbol maestro Physioguide

id: wh_master_entry

Resumen: Flujo: red flags → FOOSH/tabaquera (escafoides) → neural (STC/cubital/cervical) → radial (De Quervain) → mecánico. Nunca Phalen = STC confirmado.

Hipótesis:

- **Enrutar por trauma, territorio neural y localización** (alta) — Tabaquera → escafoides. Noche mediano → STC. Radial pulgar → De Quervain.
- Continúa en: **wh_scaphoid_gate**

2. [TEST / GATE] ¿Trauma FOOSH con dolor en tabaquera?

id: wh_scaphoid_gate

testId: route-wrist-scaphoid

Descripción: Caída sobre la mano + valle junto al pulgar → priorizar imagen (escafoides). RX inicial puede ser normal.

Procedimiento: Enrutado clínico de trauma.

Evidencia: No tranquilizar «solo esguince» sin pensar en escafoides.

- **Positivo / Sí:** FOOSH + tabaquera / sospecha ósea → **wh_scaphoid_cluster**
- **Negativo / No:** Sin sospecha escafoides dominante → **wh_neural_gate**

3. [CONCLUSIÓN] Sospecha de fractura de escafoides — priorizar imagen

id: wh_scaphoid_cluster

Resumen: FOOSH + tabaquera. No «solo esguince». RX inicial puede ser normal.

Hipótesis:

- **Fractura de escafoides (sospecha clínica)** (alta) — Cluster trauma + tabaquera.
- Nodo terminal (fin de rama).

4. [TEST / GATE] ¿Hormigueo en territorio mediano (STC)?

id: wh_neural_gate

testId: route-wrist-neural

Descripción: Noche + 1.º-3.º ± sacudir la mano → STC. Meñique solo → cubital. Cuello → cervical.

Procedimiento: Enrutado por territorio neural.

→ **Positivo / Sí:** Parestesias medianas / nocturnas → **wh_cts_cluster**

→ **Negativo / No:** Sin cuadro STC dominante → **wh_radial_gate**

5. [CONCLUSIÓN] Compatible con síndrome del túnel carpiano

id: wh_cts_cluster

Resumen: Historia nocturna + territorio mediano ± Phalen/Tinel. Tests negativos no descartan. Meñique solo ≠ STC.

Hipótesis:

- **Túnel carpiano (STC)** (alta) — Patrón clásico de parestesias medianas.
- **Referido cervical / otra neuropatía** (media) — Si cuello o territorio atípico.

→ Continúa en: **wh_phalen**

6. [TEST / GATE] ¿Dolor radial / De Quervain?

id: wh_radial_gate

testId: route-wrist-dequervain

Descripción: Borde del pulgar + uso del pulgar → De Quervain. Si no, esguince/TFCC/otro.

Procedimiento: Enrutado por localización.

→ **Positivo / Sí:** Estiloides radial / base pulgar → **wh_dequervain_cluster**

→ **Negativo / No:** Otra zona / mecánico → **wh_mechanical_cluster**

7. [TEST / GATE] Test de Phalen

id: wh_phalen

testId: phalen

Descripción: Flexión máxima de muñeca sostenida 60 s (posición de rezo).

Procedimiento: Flexión máxima de muñeca sostenida 60 s (posición de rezo).

Evidencia: D'Arcy & McGee JAMA 2000; JOSPT CTS CPG 2019: precisión moderada/mixta. Cluster (noche, sacudir la mano) > Phalen aislado. Negativo no descarta.

→ **Positivo / Sí:** Parestesias medianas familiares → **wh_cts_cluster**

→ **Negativo / No:** Phalen no familiar → **wh_tinel**

8. [CONCLUSIÓN] Compatible con De Quervain

id: wh_dequervain_cluster

Resumen: Estiloides radial + uso del pulgar ± Finkelstein familiar. Eichhoff solo da falsos positivos.

Hipótesis:

- **Tenosinovitis de De Quervain** (alta) — 1.er compartimento / pulgar.
- **Artrosis CMC / escafoides** (media) — Si trauma o base pulgar artósica.

→ Continúa en: **wh_finkelstein**

9. [CONCLUSIÓN] Patología mecánica de muñeca (sin neural/radial claro)

id: wh_mechanical_cluster

Resumen: Esguince, TFCC (lado cubital), tendinopatía. Cribar trauma previo y cervical si síntomas mixtos.

Hipótesis:

- **Esguince / sobrecarga de muñeca** (alta) — Sin cluster STC ni De Quervain típico.
- **TFCC / lado cubital** (media) — Dolor lado meñique tras torsión/apoyo.

→ Continúa en: **wh_ultr**

10. [TEST / GATE] Signo de Tinel

id: wh_tinel

testId: tinel

Descripción: Percusión sobre el nervio mediano en el túnel carpiano.

Procedimiento: Percusión sobre el nervio mediano en el túnel carpiano.

Evidencia: Complemento de Phalen (a menudo menos sensible que la historia nocturna). Parestesias en territorio mediano, no dolor local. No confirma STC solo.

→ **Positivo / Sí:** Tinel mediano familiar → **wh_cts_cluster**

→ **Negativo / No:** Tinel no familiar → **wh_ultt**

11. [TEST / GATE] Finkelstein (De Quervain)

id: wh_finkelstein

testId: finkelstein

Descripción: Desviación cubital del puño con el pulgar estabilizado (técnica de Finkelstein). Dolor en estiloides radial / 1.er compartimento familiar. No confundir con solo cerrar el puño sobre el pulgar (Eichhoff — más falsos +).

Procedimiento: Desviación cubital del puño con el pulgar estabilizado (técnica de Finkelstein). Dolor en estiloides radial / 1.er compartimento familiar. No confundir con solo cerrar el puño sobre el pulgar (Eichhoff — más falsos +).

Evidencia: Cluster De Quervain: estiloides radial + uso del pulgar + palpación ± Finkelstein. Eichhoff aislado da falsos positivos.

→ **Positivo / Sí:** Dolor estiloides radial familiar → **wh_dequervain_cluster**

→ **Negativo / No:** No familiar / otra zona → **wh_mechanical_cluster**

12. [TEST / GATE] ULTT / ULNT

id: wh_ultt

testId: ultt

Descripción: Tensión neural del mediano (depression-humeral, extensión codo/muñeca/dedos).

Procedimiento: Tensión neural del mediano (depression-humeral, extensión codo/muñeca/dedos).

Evidencia: Wainner Spine 2003: sensible, poco específico aislado. Cluster con Spurling/distracción. Tirantez ≠ hernia ni túnel carpiano.

→ **Positivo / Sí:** Tensión neural / síntomas proximales → **wh_cervical_cluster**

→ **Negativo / No:** ULTT no familiar → **wh_mechanical_cluster**

13. [CONCLUSIÓN] Compatible con componente cervical / neurodinámico

id: wh_cervical_cluster

Resumen: ULTT/Spurling apoyan referido; no confirman raíz. Integrar cuello.

Hipótesis:

· **Referido cervical / irritación neural** (alta) — Síntomas proximales o ULTT familiar.

→ Nodo terminal (fin de rama).